

Uzależnienie + *psychoza / schizofrenia*

Do 50% osób ze schizofrenią ma uzależnienie. Każde nasila przebieg drugiego. Leczenie zintegrowane jest jedyną drogą, ale wymaga doświadczonego zespołu.

CZAS: 25 min czytanie Psychoedukacja + plan

ŹRÓDŁO: Drake i wsp. (2008); Wisdom i wsp. (2011); NICE (2011, CG120)

JAK UŻYWAĆ

Karta porządkuje wiedzę o najpoważniejszej z podwójnych diagnoz — **uzależnienie + psychoza** (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, krótkotrwałe psychotyczne). Pokazuje: 1) **częstość i mechanizm**, 2) różnicowanie psychozy *indukowanej* od *pierwotnej*, 3) zasady **zintegrowanego leczenia** (IDDT), 4) co konkretnie omówić ze specjalistą.

UWAGA: aktywna psychoza wymaga niezwłocznej konsultacji psychiatrycznej — karta nie jest substytutem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Drake i wsp. (2008) wykazali: **30-50% osób ze schizofrenią ma uzależnienie** — 4-8× częściej niż w populacji ogólnej. Najczęściej: nikotyna (60-80%), alkohol (30-40%), marihuana (25-35%), stymulanty (15-20%). Mechanizm: 1) *samoleczenie* objawów negatywnych (anhedonia, izolacja) i objawów ubocznych leków, 2) *wywołanie psychozy* przez substancję (zwl. amfetamina, marihuana, syntetyczne kannabinoidy), 3) *wspólne podłoże* genetyczne. Bez zintegrowanego leczenia: 70-80% pacjentów ma ponowne hospitalizacje w pierwszym roku, śmiertelność 2× wyższa. Wisdom i wsp. (2011, metaanaliza): IDDT redukuje hospitalizacje o **40%** i poprawia jakość życia.

01 ✕ Trzy scenariusze — kiedy substancja, kiedy psychoza

A · INDUKOWANA SUBSTANCJĄ

Psychoza pojawia się **w trakcie** lub krótko po używaniu, ustępuje w **1-4 tyg. abstynencji**.

Najczęściej: amfetamina, kokaina, marihuana (zwl. wysokoTHC), LSD, kannabinoidy syntetyczne.

Leczenie: głównie abstynencja + krótkie leki przeciwpsychotyczne (2-8 tyg.), monitorowanie objawów.

B · SCHIZOFRENIA + SAMOLECZENIE

Pierwotna schizofrenia, pacjent *używa substancji* by łagodzić objawy negatywne, lęk, objawy uboczne leków. Substancja często krótko pomaga, długoterminowo pogarsza.

Leczenie: klasyczna farmakoterapia psychozy + interwencje uzależnieniowe (CRA, MI, IDDT).

C · SCHIZOFRENIA WYWOŁANA

Długie używanie wysokoTHC w okresie dojrzewania *aktywuje* schizofrenię u osób z predyspozycją genetyczną. Marihuana w wieku 14-17: 2-4× wyższe ryzyko schizofrenii (Marconi i wsp. 2016).

Leczenie: jak w pełnej schizofrenii — długoterminowe.

Rozróżnienie scenariuszy **A vs B/C** wymaga **4-6 tygodni obserwacji w abstynencji**. Jeśli objawy psychotyczne ustępują — A. Jeśli utrzymują się — B lub C.

02 📄 Co najczęściej wywołuje psychozę indukowaną

Amfetamina, metamfetamina — psychoza paranooidalna do kilku tygodni. Ryzyko nawrotu psychozy bez ponownego użycia: 30%.

Kokaina — krótkie epizody (godziny-dni), parano-idealność, omamy taktylne („robaki pod skórą”).

Marihuana wysokoTHC — szczególnie u młodzięży. Dezorganizacja myślenia, lęk paniczny, depersonalizacja.

Kannabinoidy syntetyczne („spice, K2, mocz”) — najgroźniejsze. Ciężka psychoza, drgawki, śmierć.

LSD, grzyby halucynogenne — krótkie epizody paranoiczne, omamy taktylne. Ryzyko nawrotu psychozy bez ponownego użycia: 30%.

Alkohol — psychoza alkoholowa (DT, halucynozą, omamami taktylnymi). Ryzyko nawrotu psychozy bez ponownego użycia: 30%. **Uzależnienie od alkoholu** — w trakcie ciężkiego odstawiania objawy psychotyczne.

03 Zintegrowane leczenie (IDDT) — co działa

OBSZAR	CO STOSUJEMY
<i>Farmakoterapia psychozy</i>	Leki przeciwpsychotyczne (preferowane: olanzapina, kłozapina, kwetiapina) — niektóre redukują też głód substancji
<i>Farmakoterapia uzależnienia</i>	Naltrekson, akamprozat (alkohol) — bezpieczne łączenie z neuroleptykami. Disulfiram ostrożnie.
<i>Psychoterapia</i>	MI dostosowane (krótsze, prostsze), CRA, programy społecznościowe, psychoedukacja rodziny
<i>Wsparcie społeczne</i>	Wsparcie rodziny, asystent zdrowienia, mieszkalnictwo terapeutyczne, opieka długoterminowa
<i>Czego unikać</i>	Intensywnych konfrontacyjnych podejść (program Minnesota), grup AA przy ciężkich objawach, długich grup terapeutycznych

04 Moja sytuacja + plan

CZY MIAŁEM/-AM EPIZOD PSYCHOTYCZNY

— omamy, urojenia, dezorganizacja

MÓJ KONTEKST

— A indukowana, B+ samoleczenie, C wywołana, nie wiem

MÓJ AKTUALNY PSYCHIATRA

— imię, kontakt, częstotliwość wizyt

SYGNAŁ ALARMOWY

— gdy zauważam co — natychmiast do psychiatry

UWAGA — kryzys psychotyczny: jeśli pojawiają się omamy, urojenia, znaczna dezorganizacja, agresja — natychmiastowa pomoc: 112 (zagrożenie życia), SOR psychiatryczny (w każdym dużym mieście), 800 199 990 (24h, bezpłatna konsultacja kryzysowa).

Klucz: Wisdom i wsp. (2011, metaanaliza 16 RCT n=2 731) wykazali, że IDDT (Integrated Dual Disorder Treatment) **redukuje hospitalizacje psychotyczne o 40%, zmniejsza używanie substancji o 35% i poprawia jakość życia**. Mechanizm: ten sam zespół terapeutyczny zna oba zaburzenia, nie ma „przerzucania pacjenta” między specjalistami. W Polsce IDDT jest rzadko dostępne — najbliższej tej idei: **oddziały podwójnej diagnozy** (kilkanaście w kraju, m.in. Lublin, Wrocław, Warszawa) i programy ośrodków psychiatrycznych z modułem leczenia uzależnień.